Poder Judiciário
Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul
1ª Vara Judicial da Comarca de Parobé

Av. Taquara, 470 - Bairro: Guarujá - CEP: 95630000 - Fone: (51)3098-5199 - Balcão Virtual: (51) 9 9518-4006 - Email: frparobe1vjud@tjrs.jus.br

PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL Nº 5004563-38.2022.8.21.0157/RS

AUTOR: PAULO SILVEIRA DE MELLO

RÉU: IPE-SAÚDE - INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DOS SERVIDORES PÚBLICOS DO RIO GRANDE DO SUL

SENTENÇA

I - RELATÓRIO

PAULO SILVEIRA DE MELLO ajuizou *ação ordinária* em face de **IPE-SAÚDE - INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DOS SERVIDORES PÚBLICOS DO RIO GRANDE DO SUL**. Narrou ser beneficiário do plano IPE-SAÚDE, inscrição n.º 66.96047140.00.8, tratando-se de cobertura ambulatorial e hospitalar. Mencionou que está acometido de neoplasia maligna de próstata (CID 10 C61), referindo que a doença encontra-se no estágio clínico III, *não metastática, resistente à castração*. Alegou que já esgotou os tratamentos disponibilizados pelo plano de saúde para o tratamento de sua doença, sendo indicado pelo seu médico o uso da medicação Darolutamida 300mg, 4 comprimidos, uso contínuo, sendo esta a única alternativa viável para o controle e tratamento da doença, a fim de impedir a evolução metastática. Disse que o réu negou o fornecimento do tratamento. Grifou que o fármaco foi registrado na ANVISA em dezembro de 2019 e tem indicação aprovada em bula para pacientes com o mesmo diagnóstico. Requereu liminarmente o fornecimento do medicamento. Postulou a procedência do pedido e a concessão da gratuidade de justiça (evento 1, INIC1).

Deferido o benefício da gratuidade da justiça e deferida a tutela provisória para determinar ao réu o fornecimento do fármaco pleiteado (evento 3, DOC1).

O réu noticiou o cumprimento da liminar (evento 9, DOC1).

Citado (20.1 e evento 24), o réu deixou transcorrer o prazo sem apresentar contestação.

O autor informou não ter outras provas a produzir (evento 29, DOC1).

O réu apresentou contestação (evento 30, DOC1). Defendeu que o IPE se submete ao plano de saúde de autogestão, não se confundindo com planos de saúde privados, tampouco se sujeitando à fiscalização da Agência Nacional de Saúde Suplementar (ANS). Manifestou que a assistência prestada pelo IPE advém de recursos oriundos do Fundo de Assistência à Saúde, logo não há falar em abundância de receita. Frisou que a extensão - judicial - da cobertura do IPE ofende o princípio da separação dos poderes. Pontuou que a autarquia estadual não pode ser compelida à cobertura de um tratamento que excede o previsto em seu regulamento, de custo elevado, prejudicando a coletividade associada, especialmente porque a medicação postulada não faz parte da cobertura para o tratamento da neoplasia maligna da próstata. Requereu a improcedência do pedido.

Houve réplica (evento 34, DOC1).

Vieram os autos conclusos para julgamento.

Relatei. Decido.

II - FUNDAMENTAÇÃO

Em um primeiro momento, cumpre registrar que a apresentação intempestiva de contestação pelo IPE não produz o efeito próprio da revelia, consistente na confissão ficta da matéria de fato, uma vez que não aplicável à Fazenda Pública e suas autarquias, na medida em que defendem e representam o interesse público.

Presentes os pressupostos processuais, passo à análise do mérito.

Trata-se de ação de obrigação de fazer em que a parte autora, acometida de neoplasia maligna de próstata (CID 10 C61), busca a condenação do réu ao fornecimento do medicamento Darolutamida 300mg.

A pretensão do autor encontra suporte nas Recomendações Técnicas em Oncologia do IPE Saúde, elaboradas pelo Comitê Científico de Oncologia e Hematologia da Sociedade de Cancerologia do Rio Grande do Sul e revisadas em setembro de 2019.

Tais recomendações deixam claro que seu objetivo não é interferir na conduta médica ou na autonomia profissional e que casos excepcionais e não previstos podem ser discutidos, especialmente porque *vários dos medicamentos de alto custo (biológicos) serão analisados a parte do manual*.

Essas disposições são arrematadas pelo artigo 4º da Lei Complementar n.º 15.145/2018, que aborda os procedimentos contemplados pelo plano de saúde: atendimento médico, hospitalar, ambulatorial, laboratorial, bem como dos atos necessários ao diagnóstico e aos tratamentos devidos aos usuários.

Ainda que expresso na referida lei que os procedimentos, exames, tratamentos, insumos e materiais não previstos nas tabelas no Instituto ficam excluídos de cobertura, **há laudos médicos que reforçam a condição de saúde de Paulo Silveira de Mello e a necessidade do uso do medicamento** (evento 1, DOC8):

RELATÓRIO MÉDICO

O Sr(a).PAULO SILVEIRA DE MELLO, , portador neoplasia maligna da próstata, CID-10: C61, estágio clínico III, apresenta doença NÃO metastática e resistente à castração, necessita receber o tratamento sistêmico com DAROLUTAMIDA 600 mg por via oral 2 vezes ao dia (2 comprimidos de 300 mg duas vezes ao dia), de forma contínua e ininterrupta. O paciente teve diagnóstico da neoplasia de próstata em julho de 2016, sendo submetido à radioterapia da próstata e bloqueio hormonal até julho de 2019. Apresentou recidiva bioquímica da doença em abril de 2021. Desde então, realiza bloqueio hormonal. Apesar do bloqueio, apresenta aumento progressivo do PSA, o que constitui o diagnóstico de doença resistente à castração. O uso da medicação DAROLUTAMIDA demonstrou melhora na sobrevida livre de metástases e uma tendência de melhora da sobrevida global em comparação com uso de placebo. O início deve ser imediato sob risco de progressão da doença e morte. A indicação para uso está previsto em bula com registro na ANVISA.

A necessidade, portanto, resta evidenciada pela documentação médica acostada aos autos, que indica possuir a parte autora diagnóstico de neoplasia de próstata metastática e que, em razão disso, é imprescindível o uso do medicamento Darolutamida. Da mesma forma, comprovada a urgência do tratamento, pois o fármaco pleiteado proporciona aumento da sobrevida global e diminuição do tempo de progressão da doença em pacientes com câncer de próstata metastático sensível à castração, como o autor.

Logo, considerando a gravidade da enfermidade que acomete a parte autora, não se mostra minimamente razoável limitar as alternativas terapêuticas disponíveis para o seu tratamento às listadas em protocolo que historicamente não consegue acompanhar a velocidade dos avanços da medicina, o que, caso ocorresse, configuraria efetiva negativa de adequado tratamento à parte autora, expondo-a a risco de dano irreparável à sua saúde.

Ademais, descabida a alegação do demandado de que o fornecimento da prestação de saúde, por não estar previsto nas suas tabelas vigentes à época, implicaria sobrecarga ou mesmo comprometimento do orçamento da autarquia destinado à saúde, porquanto eventual negativa, nessas circunstâncias, só poderia ocorrer com base em contestação técnica médica suficiente.

Não há prova alguma no processo que evidencie qualquer impedimento ao cumprimento da determinação judicial pelo demandado. Outrossim, a autarquia não se desincumbiu de provar que o tratamento indicado pelo médico assistente acarretaria oneração desnecessária para o Instituto.

Cito, a respeito, precedentes jurisprudenciais do Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul em sentido análogo:

APELAÇÃO CÍVEL. IPE-SAÚDE. ASSISTÊNCIA À SAÚDE. MEDICAMENTO. NEGATIVA DO INSTITUTO A PRETEXTO DE NÃO CONSTAR NO RESPECTIVO PROTOCOLO ONCOLÓGICO. TAL SITUAÇÃO NÃO EXCLUI A OBRIGAÇÃO DE COBERTURA. HONORÁRIOS RECURSAIS. JULGAMENTO MONOCRÁTICO APELAÇÃO DESPROVIDA. (Apelação Cível, Nº 50009471620218210052, Primeira Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Irineu Mariani, Julgado em: 24-06-2024).

REMESSA NECESSÁRIA. DIREITO PÚBLICO NÃO ESPECIFICADO. SAÚDE PÚBLICA. IPE-SAÚDE - INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DOS SERVIDORES PÚBLICOS DO RIO GRANDE DO SUL. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO PARA TRATAMENTO ONCOLÓGICO: PEMBROLIZUMAB. DIAGNÓSTICO DE OUTRAS NEOPLASIAS MALIGNAS DE PELE (CID 10 C44). SENTENÇA CONFIRMADA. 1. Em se tratando de sentença que condenou o demandado IPE-SAÚDE - INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DOS SERVIDORES PÚBLICOS DO RIO GRANDE DO SUL, autarquia estadual, ao custeio de tratamento em montante que supera o disposto no art. 496, §3º, é de ser conhecida da remessa necessária. 2. A pretensão da parte autora encontra guarida nas disposições do artigo 4º da Lei Complementar nº 15.145/18 e nas Recomendações em Oncologia do próprio IPE-SAÚDE – elaboradas pelo Comitê Científico de Oncologia e Hematologia da Sociedade de Cancerologia do Rio Grande do Sul - que dispõem que as orientações ali constantes "não têm pretensão de serem completas ou definitivas", restando destacado, também, que "a atuação oncológica é um fenômeno continuado que requer revisões frequentes". Assim, demonstrada a urgência, evidencia-se o acerto da determinação judicial compelindo ao fornecimento do medicamento ora postulado. 3. A relevância constitucional do direito à saúde, a previsão de cobertura para o tratamento oncológico postulado, conforme Lei Complementar nº 15.145/18 e Recomendações em Oncologia do próprio IPE-SAÚDE e as circunstâncias concretas demonstradas nos autos conduzem à confirmação da sentença proferida pelo juízo singular. SENTENÇA CONFIRMADA, EM REEXAME NECESSÁRIO. (Remessa Necessária Cível, Nº 50048283920238210049, Segunda Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Ricardo Torres Hermann, Julgado em: 19-06-2024).

AGRAVO DE INSTRUMENTO. IPE-SAÚDE. MEDICAMENTO ONCOLÓGICO NÃO PREVISTO EM TABELAS PRÓPRIAS. LEI 9.656/98. RECUSA ILEGAL. 1. O plano de saúde, inclusive no regime de autogestão, não pode excluir de sua cobertura procedimento, medicamento ou material para tratamento de doença prevista no contrato. Jurisprudência do STJ. 2. Afigura-se ilegal a recusa do IPE-SAÚDE em custear procedimentos, exames e medicamentos indispensáveis ao tratamento à saúde do segurado, ainda que que não constem das suas tabelas. Precedentes deste Tribunal. Hipótese em que há, nos autos, prova da necessidade dos medicamentos requeridos. Recurso provido. (Agravo de Instrumento, Nº 53862359320238217000, Vigésima Segunda Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Maria Isabel de Azevedo Souza, Julgado em: 08-03-2024).

Dessa maneira, evidenciado o direito ao fornecimento do medicamento postulado ao tratamento de sua patologia, imperioso o julgamento procedente da ação.

III - DISPOSITIVO

Ante ao exposto, com fundamento no artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil, **JULGO PROCEDENTE** a pretensão formulada por **PAULO SILVEIRA DE MELLO** em face do **IPE-SAÚDE - INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DOS SERVIDORES PÚBLICOS DO RIO GRANDE DO SUL**, para o fim

de **CONDENAR** a Autarquia Estadual à disponibilização de *darolutamida 300mg* ao autor, de forma contínua e por tempo indeterminado, desde que comprovada semestralmente a necessidade/manutenção do tratamento, sob pena de bloqueio de valores para custeio às suas expensas.

Isento o demandado do pagamento da Taxa Única de Serviços Judiciais, consoante o previsto no artigo 5º, inciso I, da Lei n.º 14.634/14.

Condeno o demandado ao pagamento das despesas processuais NÃO ABRANGIDAS PELA TAXA ÚNICA (artigos 14 e seguintes da Lei n.º 14.634/2014, e artigo 84 do CPC), bem como ao pagamento de honorários sucumbenciais ao procurador da parte autora, que fixo em R$ 1.500,00, nos termos do artigo 85, §8º, do CPC.

Em conformidade ao artigo 3º da Emenda Constitucional n.º 113/2021, o valor dos honorários deverá ser atualizado monetariamente pela Taxa Selic a contar da data da sua fixação; com incidência de juros moratórios, segundo o mesmo índice da Taxa Selic, a contar do trânsito em julgado, conforme artigo 85, §16, do CPC.

Sentença registrada e publicada eletronicamente. Agendada a intimação das partes.

Interposta apelação, processe-se, conforme os trâmites legais e, após, remetam-se os autos ao Tribunal de Justiça.

Após o trânsito em julgado, certifique-se e procedam-se com os atos ordinários necessários à cobrança de eventuais despesas processuais: expedição de RPV, intimações, alvarás para destinação dos valores e demais atos.

Documento assinado eletronicamente por **MARIANA FRANCISCO FERREIRA, Juíza Substituta na Titularidade Plena**, em 8/11/2024, às 17:27:22, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006. A autenticidade do documento pode ser conferida no site https://eproc1g.tjrs.jus.br/eproc/externo_controlador.php?acao=consulta_autenticidade_documentos, informando o código verificador **10071625746v10** e o código CRC **20e3cce4**.